

PANCREATITIS AGUDA

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PRONAP 2017 Módulo 1

Servicio de Gastroenterología H. Notti 2015

Sociedad Española de Pediatría 2014

Definición

Enfermedad inflamatoria del páncreas exocrino causada por activación, liberación y autodigestión de la glándula por sus propias enzimas.

Forma:

- Edematosa:
 - Suele tener un curso leve y autolimitado
- Necrotizante:
 - Hay necrosis de la grasa
 - Curso clínico fulminante y rápidamente progresivo
 - Dolor intenso
 - Fallo renal
 - Colapso circulatorio
 - Posible evolución fatal en horas o días
- Hemorrágica:
 - Posterior a las necrosis grasa

Incidencia: aumento las últimas 2 décadas, se estima entre un 3,6 a 13,2 casos/100.000/año.

Etiología

En adultos el 85% de las pancreatitis agudas son secundarias a colelitiasis y alcohol, en niños y adolescentes las etiologías son diversas.

1. **Traumatismos abdominales:** los más comunes 20 a 40% son caídas y trauma por manubrio de bicicleta o automovilísticos, CPRE, abuso y maltrato, lesión quirúrgica. Debido a que el páncreas es un órgano retroperitoneal, la ruptura es poco común y el diagnóstico puede dilatarse. El traumatismo provoca compresión del páncreas contra la columna vertebral, lo que puede producir edema, ruptura ductal con fuga de secreciones pancreáticas exógenas y la formación de pseudoquistes.
2. **Causas biliares:** representan el 5 al 20%. Producidas por ascariasis, malformaciones biliares, colelitiasis, microlitiasis y coledocolitiasis, complicaciones de la CPRE, páncreas divisum, tumores.
3. **Infecciones:** varios pacientes con PA presentan un pródromo de cuadro viral, es dificultoso determinar la verdadera incidencia de infección asociada algunas series encontraron entre el 2 al 10%. Estas causas se relacionan con ascariasis, coxsackie, VEB, VHA, VHB, influenza A-B, leptospirosis, malaria, sarampión, paperas, micoplasma, rubéola, shock séptico.
4. **Genéticas:** representan el 1 al 14%. La pancreatitis hereditaria se define como la presencia de dos casos de pancreatitis en una generación o dos o más casos de pancreatitis en más de una generación. Se ha demostrado que mutaciones en varios genes las más comunes PRSSI, CFTR y SPINK1. La fibrosis quística de páncreas (FQP) atípica puede ocurrir en pacientes con una mutación en el CFTR.
5. **Drogas:** representan el 10 al 20%

Más comunes	Acetaminofén	Retrovirales	Carbamazepina	Cimetidina	Corticoides
L-asparaginasa	Isoniazida	Lamivudine	Metildopa	Octiotide	Opiáceos
azatioprina	Tetraciclinas	Tiazidas	Veneno de escorpión	Vincristina	Organofosforados
6 mercaptopurina	Estrógenos	Simvastatina	Furosemida	Enalapril	Sulfonamidas
Ac. Valproico	Alcohol	Lamivudine	Tiazidas	Simvastatina	Eritromicina

6. **Enfermedades sistémicas:** representan el 5 al 35%. Particularmente se puede asociar con el SHU, sepsis, shock.

Clínica

- Tiene una presentación variable y síntomas que pueden ir del dolor abdominal leve a la afectación severa caracterizados por alteraciones metabólicas y shock.
- La mayoría de las PA son leves y autolimitadas, con ausencia de falla orgánica y/o necrosis, estos pacientes resuelven los síntomas rápidamente y la mortalidad es poco frecuente.
- El síntoma más frecuente es el dolor abdominal en región epigástrica puede ser brusco o de inicio gradual
- En segundo lugar náuseas y vómitos
- Se irradia al dorso en 60% de los casos
- La ingesta puede provocar aumento del dolor y vómitos
- Abdomen distendido y tenso y puede palparse una masa
- Otros síntomas:
 - Fiebre
 - Ictericia
 - Ascitis
 - Derrame pleural
 - Anorexia
 - Hipersensibilidad abdominal
 - Signo de Grey Turner y signo de Cullen
- Afectación severa:
 - Taquicardia
 - Fiebre
 - Hipotensión

Examen físico:

- Dolor abdominal con signo de rebote
- Disminución de ruido intestinal
- Signos de Grey Turner y Cullen : en niños, hay oscurecimiento de la piel en flancos y ombligo respectivamente, que son signos de pancreatitis hemorrágica
- Ascitis o derrame pleural con dificultad respiratoria, oliguria y anuria

Diagnóstico

Se realiza con al menos dos de los siguientes criterios:

1. Aumento de amilasa y/o lipasa tres veces por encima del valor de referencia.
2. Signos y síntomas clínicos de pancreatitis (dolor abdominal, vómitos, íleo u otros signos como fiebre o ictericia.
3. Evidencia de edema, hemorragia, o necrosis del páncreas por estudios de imagen.

Exámenes complementarios al Ingreso

- **Amilasemia:** varían con la técnica de laboratorio utilizada, se considera valores normales de amilasa de 0-130 U/l
- **Lipasa:** valor normal de 0 -160 U/l. Aumentada por 3 es indicativo de pancreatitis y ≥ 7 veces el valor normal dentro de las 24 h de presentación puede ser un predictor clínico de severidad.
La vida media de la lipasa es de 8 a 14 días y la de la amilasa es de 3 a 5 días
- Hemograma (puede haber hemoconcentración con aumento del Hto. y hemoglobina)
- Uremia (puede estar aumentada por la misma hemoconcentración)
- PCR cuantitativa
- Coagulograma

- Bilirrubina total, directa e indirecta (su aumento sugieren colelitiasis o coledocolitiasis)
- Transaminasas
- GGT (su aumento sugieren colelitiasis o coledocolitiasis)
- FAL
- TP, TTPK
- Urea y creatinina
- Ionograma
- Calcemia
- Glucemia
- LDH
- Albuminemia
- colesterol y triglicéridos
- Gases arteriales según gravedad
- Orina completa con pigmentos biliares

Imágenes:

- **Rx simple de abdomen:**

Diferencia de otros cuadros abdominales agudos

Puede presentarse el signo del “Asa centinela” e signos de ilio

- **Radiografía de tórax:**

Para evaluar derrame pleural

- **Ecografía abdominal:**

- Solicitarla al ingreso y luego según evolución

- Se puede observar:

- Aumento de tamaño pancreático
- Alteración de la ecogenicidad
- Calcificaciones
- Pseudoquiste
- Litiasis y barro biliar
- Alteración del tamaño de los conductos pancreáticos y biliares
- Colecciones intraabdominales

- **TAC abdominal:**

- Al ingreso: únicamente en casos de duda diagnóstica, cuando se quiera excluir otras patologías intraabdominales como diagnóstico diferencial
- Contraste endovenoso: No se recomienda al inicio de la enfermedad a menos que el diagnóstico diferencial lo amerite. Solicitarla a partir del tercer día según evolución y con consenso de la especialidad.
- Revalorará el especialista otros criterios de gravedad más específicos (**Baltazar** por ej.)

- **CPRE:**

- En pancreatitis recurrente (Páncreas divisum, litiasis), pancreatitis hereditaria y pancreatitis aguda que sigue al trasplante hepático.
 - Colangiopancreatografía RMN: En obstrucción del sistema pancreatobiliar.

Criterios de gravedad durante la valoración inicial:

Potencialmente Grave:

1. Presencia de 1 o más signos de falla orgánica:

- Shock
- Insuficiencia respiratoria
- Insuficiencia Renal
- Hemorragia gastrointestinal grave

2. signos de alarma

- Obesidad, menor de 7 años de edad, defensa abdominal, derrame pleural, alteración de la conciencia
- PCR mayor a 150 mg/L o elevación progresiva en 48 hs., Hto mayor 44%, procalcitonina superior a 0.5 mg/ml en las primeras 24 hs.
- Rx: derrame pleural y líquido libre peritoneal.

3. Presencia de más de tres criterios de DeBanto y col

Al ingreso.

1. < 7 años
2. < 23 Kg
3. Leucocitosis > 18.500
4. LDH > 2000 U/l

A las 48 horas.

1. Calcemia < 8.3mg/dl
2. Albúmina < 2.5
3. BUN >5 (Uremia/2.14)
4. Secuestro de líquidos estimado > de 75 ml/Kg

Aquellos con puntuación ≥ 3 al ingreso deben enviarse a terapia intensiva para monitorización continua; si a las 48 h la puntuación es ≤ 2 pueden transferirse a la sala.

Tratamiento

El objetivo debe ser aliviar el dolor y restablecer la homeostasis metabólica.

1. Hidratación Endovenosa: 3.000 ml/m²/día con solución fisiológica en dextrosa al 5% (400 ml sol. Fisiológica +100 ml dextrosa al 25%), más aporte de K de acuerdo a Ionograma, debe realizarse por calorías metabolizadas (Hasta 10 Kg: 2 mEq/kg/día; 10 a 20 Kg: 1 mEq/kg/día; más de 20 Kg: 0,5 mEq/kg/día).

Mantener ritmo diurético de 1 a 2ml/kg/h. Cuando el ritmo diurético supere los 4 ml/kg/h iniciar descenso de la hiperhidratación. Si el paciente tiene diuresis menos de 1 ml/kg/h y balance (+), sospechar tercer espacio. No utilizar diurético en este caso y optimizar el intravascular.

2. Tratamiento del dolor:

- a. La indometacina, el acetaminofén IV y el ketorolac parecen ser medicaciones aceptadas (PRONAP).
- b. Meperidina: se maneja en adultos, tiene una duración más corta que la morfina y el riesgo de la aparición de metabolitos neurotóxicos en dosis repetidas. Es utilizada actualmente en el H. Notti a 0.5 a 2mg/kg/dosis, cada 4 a 6 hs. (Dosis Máxima 7,5mg/Kg/día) (Mantener 48hs e ir descendiendo 25% gradualmente según evolución del cuadro de dolor).
- c. Morfina está generalizado a pesar de que puede provocar espasmo del esfínter de Oddi y exacerbar la PA, los datos son limitados y contradictorios respecto a que la morfina sea significativamente diferente a la de otros opioides.

3. Bloqueadores de bomba de protones: Omeprazol para evitar úlceras por estrés.

4. Antibióticos:

No profilácticos, Si existe fiebre en la segunda semana o desarrollo de fiebre tardía se debe realizar TAC, si se observan tejidos necróticos se debe realizar aspiración con aguja fina y cultivo, no se recomienda el uso de antibióticos en la necrosis estéril. Cuando existe necrosis pancreática infectada el tratamiento incluye Carbapenemicos , quinolonas y metronidazol.

5. Nutrición:

En Pancreatitis leve, cuando se controla adecuadamente el dolor y aparezcan signos de tránsito intestinal, se debe iniciar la nutrición precozmente en las primeras 72 hs (H. Notti: usualmente en 4 a 5 días del ingreso), esto modula la respuesta inflamatoria sistémica.

Usar la vía entérica en forma preferencial.

En el caso que exista mucho dolor o intolerancia oral se indica sonda enteral avanzada.

Existen recomendaciones sobre el uso de prebióticos.

Un aumento de lipasa o amilasa se asocia a la realimentación y no implica empeoramiento y no se debe suspender la nutrición enteral.

Alimentación Parenteral: cuando no se puede realizar alimentación enteral y/o pancreatitis grave.

6. Balance cada 6 hs las primeras 48 hs y de acuerdo a evolución.

7. Sonda nasogástrica inicial en íleo paralítico o pacientes con náuseas o vómitos.

8. Otros controles y tratamiento:

- Hiperglucemia: corregir cuando es mayor a 250 mg/dL.
- Hipocalcemia: corregir a partir del segundo día con gluconato de calcio.
- La indicación de CPRE puede ser necesaria en los casos de obstrucción biliar por litiasis especialmente en los que desarrollan colangitis.
- En la PA traumática se requiere cirugía frecuentemente.
- En los niños con PA no traumática se puede requerir cirugía para drenaje y resección del material necrótico o abscesos. En el paciente estable la cirugía debe ser diferida hasta después de la segunda a cuarta semana para poder diferenciar entre necrosis y tejido viable.
- En la PA biliar se recomienda la colecistectomía antes del alta, para prevenir episodios recurrentes.

Control y seguimiento:

A los 3 meses post-alta control analítico y con Eco para comprobar recuperación completa.

COMPLICACIONES

Locales:

- Pseudoquiste:
 - Más frecuente
 - Evaluado por Eco
 - En general se resuelve solo o por aspiración dirigida por Eco
 - Aparece aproximadamente a las 2 semanas
- Necrosis
- Necrosis infectada, Tratamiento: Ampicilina-sulbactam o Ampicilina + Gentamicina + Metronidazol
- Ascitis
- Hemorragia
- Absceso: originado en una región de necrosis, si es infecta se realiza drenaje no quirúrgico + ATB
- Perforación u obstrucción intestinal
- Fístula

Sistémicas:

- Shock, Coagulopatías, Derrame pleural, Fallo renal, Sepsis, Fallo multiorgánico

PANCREATITIS CRÓNICA

Proceso inflamatorio crónico, consecuencia de la destrucción del tejido pancreático exocrino, fibrosis y, en algunos casos, pérdida de la función pancreática endocrina.

A diferencia de su forma aguda, que se define por criterios clínicos, la pancreatitis crónica se define por criterios morfológicos.

Etiología

- La pancreatitis crónica es rara en niños
- Habitualmente asociada a alteraciones genéticas como fibrosis quística, pancreatitis hereditaria o idiopática.
- **Tóxico-metabólica**
 - Medicación
 - Hiperlipidemia
 - Hipercalcemia
 - Toxinas
- **Genética**
 - Fibrosis quística
 - Pancreatitis hereditaria
 - Mutaciones SPINK1
- **Obstructiva**
 - Páncreas divisum
 - Inserción anómala del conducto pancreático
 - Tumor
 - Enfermedad de Crohn
 - Estenosis ductales post-traumáticas
- **Idiopática**
- **Autoinmune**
 - Enfermedad vascular

Cuadro clínico

- Episodios recurrentes de pancreatitis aguda
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal
- En otros no aparecen episodios agudos y presentan una forma clínica de dolor continuo o intermitente de intensidad variable
- En un pequeño porcentaje de casos, el diagnóstico de pancreatitis crónica debe ser considerado en pacientes con diabetes mellitus, malabsorción e ictericia obstructiva de causa indeterminada.
- La edad de comienzo, la progresión de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad varían en función de la etiología y la gravedad del proceso pancreático.
- En general, la intensidad y frecuencia del dolor mejora a medida que progresa la enfermedad.
- La malabsorción de grasas ocurre cuando la secreción de lipasa disminuye más del 97% de la secreción normal, lo que conlleva deposiciones esteatorreicas.

Morfología:

- Pancreatitis calcificada crónica
- Pancreatitis obstructiva crónica

Tratamiento:

- Similar pancreatitis aguda
- Avanzado: suplementos enzimáticos